

Evaluación del riesgo suicida

1. Introducción y relevancia clínica

El **suicidio** representa una de las principales causas de muerte prevenible en el mundo.

Según la **OMS (2023)**, cerca de **700.000 personas mueren por suicidio cada año**, y por cada caso consumado se estima que hay al menos **20 intentos**.

En Chile, la tasa de suicidio se ha mantenido entre **10 y 12 por 100.000 habitantes**, con un preocupante aumento en **adolescentes y adultos mayores**.

El médico general —especialmente en atención primaria y urgencias— cumple un rol esencial en la **detección temprana, contención y derivación oportuna** de pacientes con riesgo suicida.

Por eso, el EUNACOM evalúa con frecuencia este tema tanto en el componente teórico como en el **ECOE**, a través de casos clínicos de depresión, intento suicida o ideación activa.

□ La **evaluación sistemática del riesgo suicida** debe realizarse en *toda consulta psiquiátrica o de salud mental*, especialmente ante depresión, consumo de alcohol o antecedentes de intentos previos.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El suicidio no es un evento súbito o aislado: es el **resultado final de un proceso progresivo** en el que interactúan **factores biológicos, psicológicos y sociales** (modelo biopsicosocial).

2.1. Factores biológicos

- **Disregulación serotoninérgica:** niveles bajos de 5-HIAA (metabolito de serotonina) en LCR se asocian con mayor impulsividad y riesgo suicida.
- **Anomalías neuroendocrinas:** hiperactividad del eje hipotálamo–hipófisis–adrenal (respuesta al estrés).
- **Genética:** historia familiar de suicidio incrementa 3 a 5 veces el riesgo.
- **Trastornos psiquiátricos:** depresión mayor, bipolaridad, esquizofrenia y abuso de sustancias son responsables de hasta **90%** de los suicidios.

2.2. Factores psicológicos

- Desesperanza, sentimiento de inutilidad o culpa.
- Impulsividad y baja tolerancia a la frustración.
- Perfeccionismo o rigidez cognitiva.
- Pérdida de sentido vital o ruptura de vínculos afectivos.

2.3. Factores sociales

- Aislamiento, soledad, pérdida de apoyo.
- Duelo reciente, desempleo, dificultades económicas.
- Violencia intrafamiliar o abuso.
- Acceso a medios letales (armas, pesticidas, medicamentos).

□ El **suicidio es multifactorial**: combina vulnerabilidad biológica con estresores psicológicos y sociales. No existe “una causa única”.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Conceptos clave

Concepto	Definición
Ideación suicida	Pensamientos de muerte o de terminar con la vida.
Plan suicida	Elaboración concreta de un método, lugar o momento.
Intento suicida	Conducta autolesiva con intención de morir, independientemente del resultado.

Gesto suicida	Conducta autolesiva sin clara intención letal (p. ej., corte superficial para pedir ayuda).
----------------------	---

Suicidio consumado	Muerte autoinfligida intencionalmente.
---------------------------	--

3.2. Tríada del riesgo suicida

1. **Deseo de morir.**
2. **Medios disponibles.**
3. **Ausencia de apoyo o esperanza.**

A mayor presencia de estos tres factores, mayor riesgo de suicidio consumado.

3.3. Manifestaciones clínicas

El paciente con ideación suicida puede manifestar:

- Expresiones directas: “No quiero seguir viviendo”, “Sería mejor si no estuviera aquí”.
- Conductas de despedida: regalar pertenencias, arreglar papeles, notas.
- Cambios de ánimo: depresión profunda o aparente “tranquilidad” tras decidir suicidarse.
- Abandono del autocuidado o consumo excesivo de alcohol/fármacos.

☐ En adolescentes, el riesgo puede presentarse como **impulsividad, conductas de riesgo o aislamiento**, sin verbalización directa.

3.4. Diagnóstico diferencial

- **Trastornos facticios o simulación:** busca ganancia secundaria (evitar juicio, internación).

- **Autolesiones no suicidas:** buscan alivio emocional, no la muerte.
 - **Trastornos psicóticos:** el suicidio puede ser respuesta a delirios o alucinaciones (“voces que ordenan”).
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico de riesgo suicida es **clínico**, basado en la entrevista y el juicio profesional.

Sin embargo, ciertos **instrumentos estandarizados** ayudan a objetivar el riesgo:

Instrumento	Descripción	Uso
Escala de Columbia (C-SSRS)	Evalúa ideación y conducta suicida (OMS y MINSAL)	Atención primaria y urgencia
Beck Scale for Suicide Ideation (BSSI)	Cuantifica ideación y plan suicida	Clínica especializada
PHQ-9 (ítem 9)	Tamizaje de ideación suicida en depresión	APS
MINI – módulo C	Entrevista estructurada de riesgo suicida	APS y hospitales

Evaluación complementaria:

- **Laboratorios básicos:** descartar intoxicación, efectos de fármacos.
 - **Evaluación toxicológica:** ante intento con sobredosis.
 - **Interconsulta psiquiátrica urgente:** obligatoria ante riesgo alto o intento reciente.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1. Principios generales

- Todo intento suicida debe ser considerado grave.
 - El paciente debe ser **evaluado por psiquiatría o salud mental** antes del alta.
 - La **contención y seguimiento** son tan importantes como el tratamiento farmacológico.
-

5.2. Manejo en atención primaria (APS)

Según la **Guía MINSAL de Prevención del Suicidio (2022)**:

1. Evaluar riesgo suicida inmediato:

- Ideación activa + plan + acceso a medios = riesgo alto → derivar de urgencia.
- Si ideación pasiva sin plan, asegurar seguimiento cercano.

2. Medidas iniciales:

- Entrevistar con empatía, sin juicios.
- No minimizar ni desafiar los pensamientos suicidas.
- Retirar medios letales del entorno (fármacos, armas).
- Contactar red de apoyo familiar o social.

3. Derivación según nivel de riesgo:

Riesgo	Características	Manejo
Alto	Plan concreto, medios disponibles, desesperanza, intento reciente	Derivación inmediata a urgencia u hospitalización psiquiátrica

Moderado	Ideación sin plan definido, apoyo parcial	Derivar a salud mental ambulatoria, control en 24–48 h
Bajo	Ideación pasiva, factores protectores presentes	Seguimiento en APS, psicoterapia, control semanal

4.

Registro clínico obligatorio del riesgo, plan de acción y contactos de apoyo.

5.3. Manejo en urgencias u hospital

- Evaluación médica completa y tratamiento de lesiones.
- Contención emocional y vigilancia constante.
- Evaluación psiquiátrica urgente.
- **Hospitalización** si riesgo alto o ausencia de red de apoyo.
- Farmacoterapia según diagnóstico de base (p. ej., ISRS en depresión, antipsicóticos si psicosis).
- **Evitar prescripción excesiva de fármacos potencialmente letales.**

5.4. Intervenciones complementarias

- **Psicoterapia cognitivo-conductual:** reduce recaídas.
 - **Terapia familiar:** mejora apoyo y adherencia.
 - **Intervenciones comunitarias:** seguimiento telefónico, visitas domiciliarias (Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio 2021–2030).
 - **Restricción del acceso a medios letales:** medida de prevención más efectiva según OMS.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones del manejo inadecuado

- Reintento suicida (30–40% dentro del primer año).
- Muerte por suicidio consumado.
- Deterioro funcional y desconfianza en el sistema de salud.

Factores de mal pronóstico

- Intento previo (mayor predictor).
- Trastorno depresivo o bipolar no tratado.
- Abuso de alcohol o drogas.
- Aislamiento social, pérdida reciente.
- Acceso fácil a medios letales.

Factores protectores

- Apoyo familiar fuerte.
- Creencias religiosas o sentido de propósito.
- Acceso a tratamiento.
- Buena adherencia terapéutica.

☐ La **vigilancia activa post intento suicida** reduce el riesgo de muerte hasta en un 50%.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐

Perlas clínicas

1. El **mayor predictor de suicidio** es un intento previo.

2. **Preguntar directamente por ideación suicida no aumenta el riesgo**, mejora la detección.
 3. **Depresión, bipolaridad y consumo de alcohol** son los principales factores de riesgo.
 4. **Todo intento suicida requiere evaluación psiquiátrica antes del alta.**
 5. En Chile, el **MINSAL** dispone de la **Guía de Prevención del Suicidio (2022)** y la **Estrategia Nacional 2021–2030**.
 6. El riesgo es **dinámico**, puede cambiar día a día según apoyo y estresores.
 7. En EUNACOM, las preguntas suelen evaluar **clasificación del riesgo y manejo inicial correcto**.
-



Errores comunes

- Pensar que el paciente “solo quiere llamar la atención”.
 - No registrar el riesgo en la ficha clínica.
 - Dar el alta sin derivación o sin contactar red de apoyo.
 - Recetar fármacos peligrosos sin supervisión (p. ej., amitriptilina).
 - Omitir seguimiento tras un intento suicida leve.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **suicidio es prevenible** y su evaluación es deber ético y clínico de todo médico.
2. El **riesgo suicida** debe evaluarse sistemáticamente en toda consulta psiquiátrica o de salud mental.
3. Factores principales: **intento previo, depresión, desesperanza, aislamiento, acceso a medios**.

4. Utilizar herramientas estandarizadas: **C-SSRS, PHQ-9, MINI.**
5. **Riesgo alto = derivación urgente o hospitalización.**
6. El manejo debe incluir **contención, red de apoyo, psicoterapia y farmacoterapia.**
7. Registrar siempre la evaluación, plan de acción y contactos familiares.